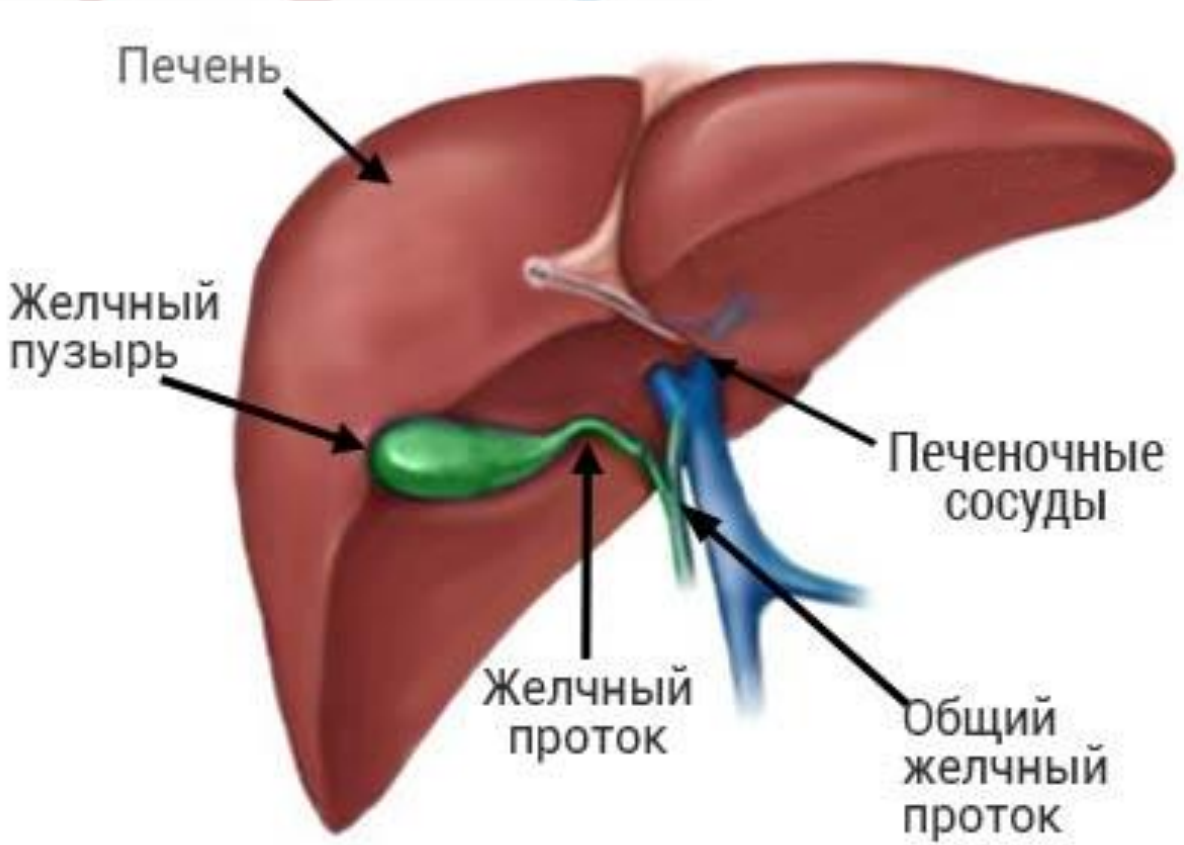

ПЕЧЕНЬ

Печень — это паренхиматозный орган пищеварительной системы и крупнейшая железа организма, расположенная в правом подреберье, под диафрагмой. Средняя масса печени взрослого человека 1,5- 2 кг.
Печень имеет две доли: правая и левая.
Имеет систему желчных протоков.
Она обладает хорошей способностью к регенерации.

Симптомы болезни печени часто проявляются на поздних стадиях, включая желтуху, тяжесть в правом подреберье, постоянную усталость, кожный зуд, потемнение мочи, посветление кала, отеки и асцит (увеличение живота).
Распространены нарушения пищеварения: тошнота, горечь во рту, потеря аппетита, а также сосудистые звездочки и кровоподтеки.



Основные функции печени:

1. *Метаболическая:*
Регулирует обмен углеводов, жиров (синтез холестерина) и белков.
Преобразует глюкозу в гликоген (запас энергии).
Накапливает витамины (A, D, B12) и микроэлементы (железо, медь).

2. Детоксикационная (Обезвреживающая):
Нейтрализует яды, алкоголь, лекарства и продукты метаболизма (например, аммиак превращает в мочевину).

3. Пищеварительная:
Производит желчь, необходимую для расщепления жиров и всасывания питательных веществ.

***4. Синтетическая*:**
Синтезирует белки плазмы крови, холестерин, фосфолипиды.

5. Гемостатическая (Свертывающая):
Производит факторы свертывания крови.

6. Выделительная:
Удаляет из организма избыток гормонов, билирубин и токсины.

7. Депонирующая (Накопительная):
Служит резервуаром крови, гликогена, витаминов и минералов.

Гепатит

Гепатитами называют группу воспалительных болезней печени. Он бывает в острой и хронической форме. Вызывается различными причинами: вирусы, употребление алкоголя, определенные лекарства или аутоиммунные нарушения.

При любом виде гепатита повреждаются гепатоциты (печеночные клетки). Серьезную опасность представляет вирусная природа заболевания. Патоген попадает в организм, начинает активно развиваться, используя механизмы гепатоцитов для своего размножения. Это приводит к воспалению и увеличению размеров органа. Агент может мутировать в организме, что нередко осложняет лечение.

Типы:

Гепатит А (болезнь Боткина). Он вызывается РНК-вирусом и наносит прямой ущерб клеткам, но не остается в них навсегда. Болезнь передается фекально-оральным путем, и время от заражения до появления симптомов обычно составляет от 15 до 45 дней. Симптомы могут включать желтушность кожи или ее отсутствие. В большинстве случаев болезнь завершается выздоровлением без хронических последствий. Вирус и инфицированные клетки полностью удаляются макрофагами (защитные агенты) из организма.

Гепатит В (серозный/инфекционный). Заболевание провоцируется ДНК-вирусом, имеет инкубационный период от 40 до 180 дней. Передается через кровь (например, при инъекциях, переливаниях) и половым путем. Патоген не прямо повреждает клетки. Он размножается в гепатоцитах, лимфоцитах, макрофагах. За разрушение зараженных элементов и удаление вируса ответственны клетки иммунной системы.

Гепатит С (HCV). Болезнь вызывается РНК-содержащим вирусом, обладающим липидной оболочкой. Его инкубационный период составляет от 15 до 150 дней. Основной путь передачи — через кровь или другие инфицированные биологические жидкости. Для диагностики существуют специальные серологические реакции, но прямых маркеров нет, что делает его обнаружение сложным. Гепатит С находится в клетках печени, также может присутствовать в лимфоцитах и макрофагах. Он наносит серьезный ущерб организму и способен вызвать нарушения в иммунной системе. Заболевание быстро прогрессирует и может привести к циррозу и раку.

Гепатит D (Дельта). Заболевание провоцируется дефектным РНК-вирусом при условии уже имеющегося антигена вируса В. Если человек заражается В и D одновременно, то развивается острая форма патологии. Если заражение происходит на фоне уже имеющегося гепатита В, т.е. D присоединяется, то это приводит к прогрессированию заболевания, вплоть до развития цирроза.

Гепатит Е (эпидемический). Он обычно передается через загрязненную воду или пищу, при контакте с зараженными людьми и животными. Протекает в острой форме, на начальной стадии — симптомы похожи на грипп. В большинстве случаев исчезает сам по себе без серьезных последствий. Переходит в хроническую форму у пациентов с ослабленным иммунитетом и беременных.

Цирроз печени — хроническое заболевание печени, сопровождающееся необратимым замещением паренхиматозной ткани печени фиброзной соединительной тканью.

Причины его развития различны: употребление алкоголя, инфекции (вирусы гепатита), токсины, а также наследственные и метаболические нарушения. Под воздействием этих факторов происходит постепенное повреждение гепатоцитов.

Цирроз может привести к повышению давления в венозной системе (портальная гипертензия). При развитии синдрома портальной гипертензии и отеков увеличивается объем живота (асцит) и наблюдается расширение кровеносных сосудов, так называемая «голова медузы».

Для цирроза характерны общие симптомы: слабость, пониженная трудоспособность, неприятные ощущения в животе, запах ментола из ротовой полости, диспепсические расстройства, повышение температуры тела, боли в суставах, также отмечаются метеоризм, боль и чувство тяжести в верхней половине живота, похудение, астения.



Печеночная энцефалопатия (ПЭ) — это потенциально обратимое нарушение работы мозга, которое возникает из-за того, что поврежденная печень (обычно при циррозе) не может очищать кровь от токсинов, в первую очередь от аммиака

«Голова медузы»



Гепатостеатоз (жировой гепатоз, «ожирение печени») — это избыточное накопление жира в клетках печени.

Причины: Основные факторы — избыточный вес, сахарный диабет 2 типа, высокий уровень холестерина и злоупотребление алкоголем.



Диагностика

Лабораторные методы:

- общий анализ крови, биохимический анализ крови;
- копрограмма;
- печеночные пробы (АЛТ, АСТ);
- определение протромбинового индекса;
- уровень билирубина и щелочной фосфатазы;
- фибриноген (фактор свертываемости крови);
- общий белок, липидный профиль;
- пробы на гепатит A, B, C, D, E и антитела;
- ферритин

К *инструментальным методам* диагностики относят:

• УЗИ органов брюшной полости;

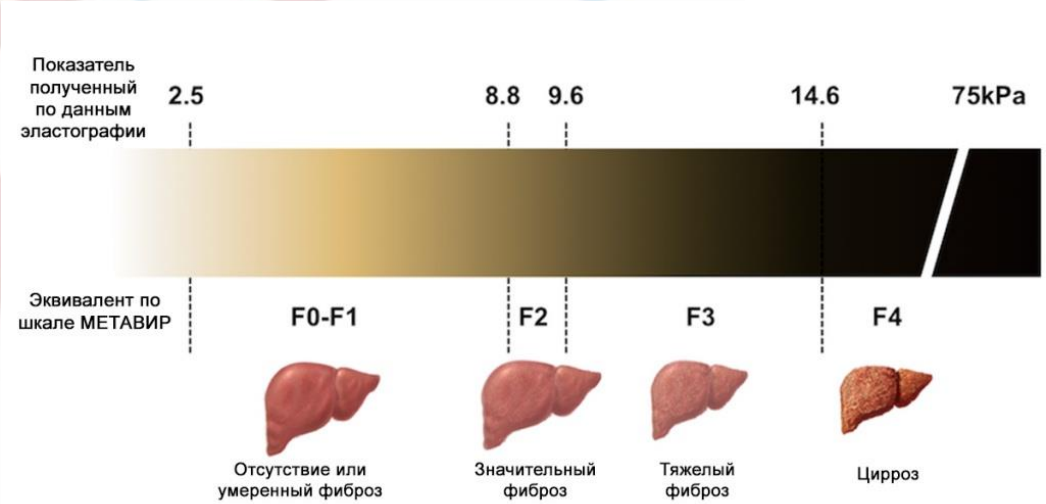
• ангиография (для оценки печеночного кровотока);

• КТ или МРТ с контрастированием и без него;

• Эластометрия/эластография (анализ плотности и эластичности тканей);

• ФЭГДС (при необходимости);

• пункционная биопсия.



Лечение

• гепатопротекторы (лекарства, защищающие паренхиму);

• витаминные комплексы;

• средства для оттока желчи;

• антигельминтные препараты (если причина поражения — паразиты).

Гепатопротекторы — это группа лекарственных средств, предназначенных для защиты и восстановления клеток печени (гепатоцитов) при токсических, вирусных и жировых поражениях.

Препараты:

1. Эссенциальные фосфолипиды: восстанавливают структуру мембран (Эссенциале Форте, Фосфоглив, Резалют Про).
2. Слимарин
3. Адеметионин *400 мг*
4. Глутатион *600 и 1200 мг*
5. Л- орнитин- Л- аспартат
6. Липоевая кислтота *300 и 600 мг*

